SIGUR PE FIECARE PACIENT™

30 de cazuri clinice pas cu pas

De la plângerea pacientului la harta din atlas: evaluarea, raționamentul, ce aștepți și când te oprești.

Atlas de Taping · Material educațional pentru profesioniști și studenți din domeniul sănătății. Nu înlocuiește diagnosticul medical.

Cuprins

1 · Cum citești un caz

2 · Umăr

3 · Cervicală și trapez

4 · Coloana toracică și scapula

5 · Zona lombară și sacrul

6 · Abdomen

7 · Șold și fesieri

8 · Coapsă și ischiogambieri

9 · Genunchi și rotulă

10 · Gambă

11 · Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

12 · Încheietura mâinii și mâna

13 · Cot și antebraț

Pasul următor

PARTEA 1

Cum citești un caz

Același raționament, de 30 de ori.

1. **Pacientul și plângerea:** cine e și ce simte, cu cuvintele lui.
2. **Evaluarea:** testele din ghidul de teste, comparând cu partea sănătoasă.
3. **Raționamentul:** de ce alegi harta asta și nu alta.
4. **Harta:** numărul exact din atlas, cu tăietura și tensiunea.
5. **Ce aștepți:** o schimbare realistă la retest, nu o vindecare.
6. **Semnalul de alarmă:** ce te face să te oprești și să trimiți la medic.

PARTEA 2

Umăr

4 cazuri.

1. Înotătorul cu umărul dureros

Umăr

PACIENTUL	Bărbat, 24 de ani, înot de 5 ori pe săptămână.
PLÂNGEREA	Durere în partea din față și laterală a umărului drept, mai ales la brațul ridicat peste cap.
EVALUAREA	Jobe + (durere, fără slăbiciune). Arcul dureros + între 70° și 120°. Aprehensiune -.
RAȚIONAMENTUL	Două teste pozitive pe structurile subacromiale, fără instabilitate: obiectivul e suportul supraspinosului și al deltoidului, nu stabilizarea.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 62** · Combinată — Umăr: Deltoid + Supraspinos · Y + I · Ambele 15–25%
CE AȘTEPȚI	Arcul dureros mai puțin intens la retest; antrenamentul redus 1–2 săptămâni, cu exerciții pentru coafa rotatorilor.

Semnal de alarmă: Slăbiciune reală la Jobe sau durere noaptea care nu cedează: trimite la medic.

2. Instalatorul cu brațul ridicat toată ziua

Umăr

PACIENTUL	Bărbat, 46 de ani, lucrează cu brațele deasupra capului.
PLÂNGEREA	Durere difuză pe tot umărul, oboseală la sfârșitul zilei.
EVALUAREA	Arcul dureros -. Palpare: deltoidul sensibil anterior și posterior. Rotație externă -.
RAȚIONAMENTUL	Fără punct clar și fără teste specifice pozitive: durere musculară difuză pe deltoid, deci Y care înconjoară mușchiul.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 3** · Umăr — Deltoid · tăietură în Y · Ancoră 0% · benzi 15–25%
CE AȘTEPȚI	Oboseală mai mică la sfârșitul zilei; pauze la 45 de minute de lucru cu brațele sus.

3. Studenta cu durere în față la umăr

Umăr

PACIENTUL	Femeie, 21 de ani, sală de forță.
PLÂNGEREA	Durere în fața umărului la flotări și la împins de la piept.
EVALUAREA	Speed +. Jobe -. Palpare dureroasă pe șanțul bicipital.
RAȚIONAMENTUL	Testul Speed pozitiv și palpare pe tendon: porțiunea lungă a bicepsului.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 4** · Umăr — Biceps (Porțiunea Lungă) · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
CE AȘTEPȚI	Durere mai mică la Speed; exercițiile de împins reduse pentru 2 săptămâni.

4. Jucătorul de volei cu umăr „care iese”

Umăr

PACIENTUL	Bărbat, 19 ani, volei.
PLÂNGEREA	Senzație de instabilitate la serviciu, fără luxație recentă.
EVALUAREA	Aprehensiune + (senzație, fără durere mare). Rotație externă: forță păstrată.
RAȚIONAMENTUL	Instabilitate fără traumatism recent: banda de stabilizare ca suport proprioceptiv, împreună cu exerciții.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 5** · Umăr — Stabilizare (Y + I) · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50%
CE AȘTEPȚI	Încredere mai mare la mișcare; banda nu înlocuiește programul de stabilizare.

Semnal de alarmă: Luxație în antecedente sau senzație de instabilitate la gesturi uzuale: evaluare medicală.

PARTEA 3

Cervicală și trapez

3 cazuri.

5. Programatoarea cu ceafa încordată

Cervicală și trapez

PACIENTUL Femeie, 32 de ani, 9 ore pe zi la calculator.

PLÂNGEREA Tensiune pe ceafă și pe umeri, dureri de cap spre seară.

EVALUAREA Palpare: puncte dureroase pe trapezul superior, bilateral. Postura: capul proiectat înainte.

RAȚIONAMENTUL Două probleme: trapezul și postura. Se încep cu harta combinată pentru trapez, iar dacă postura e problema principală, cu cele două benzi în I.

HARTA DIN ATLAS

Harta 65 · Combinată — Cervical: Y + Trapez · Y + I · Ambele 15–25%

Harta 9 · Cervicală — Postură (Două Benzi În I) · două tăieturi în I · Ancore 0% · benzi 15–25%

CE AȘTEPȚI Mai puțină tensiune la sfârșitul zilei; ecranul la nivelul ochilor și pauze.

6. Șoferul cu gâtul blocat dimineața

Cervicală și trapez

PACIENTUL Bărbat, 51 de ani, șofer de camion.

PLÂNGEREA Durere la unghiul omoplatului spre gât, nu poate întoarce capul complet.

EVALUAREA Testul de lungime al ridicătorului scapulei +. Fără iradiere în braț.

RAȚIONAMENTUL Test specific pozitiv pe ridicătorul scapulei, fără semne neurologice.

HARTA DIN ATLAS

Harta 8 · Cervicală — Ridicătorul Scapulei · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

CE AȘTEPȚI Rotația capului mai liberă la retest.

Semnal de alarmă: Durere care coboară în braț sau amorțeală în degete: nu aplica, trimite la medic.

7. Pacienta cu gâtul umflat după intervenție

Cervicală și trapez

PACIENTUL	Femeie, 58 de ani, la 3 săptămâni după o intervenție la gât, cu acordul medicului.
PLÂNGEREA	Senzație de greutate și ușoară umflătură laterală pe gât.
EVALUAREA	Edem moale, fără căldură sau roșeață. Cicatrice închisă.
RAȚIONAMENTUL	Obiectivul e drenajul, cu tensiune aproape zero, departe de cicatrice.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 10** · Cervicală — Ștergere Limfatică · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 0–20%
CE AȘTEPȚI	Senzație de ușurare; edemul se evaluează la fiecare ședință.

Semnal de alarmă: Cicatrice deschisă, roșeață, căldură sau febră: nu aplica.

PARTEA 4

Coloana toracică și scapula

3 cazuri.

8. Violonistul cu durere între omoplați

Coloana toracică și scapula

PACIENTUL Bărbat, 38 de ani, violonist.

PLÂNGEREA Durere arzătoare între omoplați după repetiții lungi.

EVALUAREA Retracția scapulelor contra rezistenței +. Palpare dureroasă pe romboizi.

RAȚIONAMENTUL Romboizii suprasolicitați de postura susținută: Y pe romboizi; dacă și postura e cauza, harta combinată.

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 41** · Toracic — Romboizi · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
- **Harta 71** · Combinată — Toracic: Postură + Romboizi · două I + Y · Toate 15–25%

CE AȘTEPȚI Durere mai mică după repetiții; pauze la 30–40 de minute.

9. Alpinista cu umerii rotați înainte

Coloana toracică și scapula

PACIENTUL Femeie, 29 de ani, escaladă.

PLÂNGEREA Umerii „căzuți” înainte și oboseală între omoplați.

EVALUAREA Observarea scapulei: marginea medială ușor dezlipită. Dorsalul mare scurtat la test.

RAȚIONAMENTUL Postura scapulei și un dorsal mare scurtat: suport scapular combinat.

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 71** · Combinată — Toracic: Postură + Romboizi · două I + Y · Toate 15–25%
- **Harta 43** · Toracic — Dorsalul Mare · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%

CE AȘTEPȚI Poziție mai bună a scapulei la retest; exerciții de întărire pentru trapezul mijlociu.

10. Pacientul cu durere la coastă după tuse

Coloana toracică și scapula

PACIENTUL	Bărbat, 44 de ani, după o răceală cu tuse lungă.
PLÂNGEREA	Durere pe coaste laterale la respirația adâncă.
EVALUAREA	Palpare dureroasă intercostală, fără traumatism.
RAȚIONAMENTUL	Durere musculară intercostală: evantai cu tensiune mică.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 44** · Toracic — Coaste Și Intercostali · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 10–20%
CE AȘTEPȚI	Respirație mai confortabilă.

Semnal de alarmă: Durere toracică la efort, febră sau dificultăți de respirație: trimite urgent la medic.

PARTEA 5

Zona lombară și sacrul

4 cazuri.

11. Curiera cu durere lombară locală

Zona lombară și sacrul

PACIENTUL Femeie, 35 de ani, ridică pachete toată ziua.

PLÂNGEREA Durere jos pe spate, pe un punct exact, fără iradiere.

EVALUAREA Flexia trunchiului +, locală. SLR -. Punct dureros clar la palpare.

RAȚIONAMENTUL Durere localizată fără semne neurologice: stea pe punct; dacă toată zona e încordată, harta combinată.

HARTA DIN ATLAS

Harta 11 · Lombar — Stea (Durere Locală) · stea din benzi în I · Centru 25–50% · capete 0%

Harta 61 · Combinată — Lombar: Două I + Stea · două I + X · I 15–25% · X centru 25–50%

CE AȘTEPȚI Flexie mai liberă la retest; tehnica de ridicare corectată.

12. Grădinarul cu durere pe o parte a spatelui

Zona lombară și sacrul

PACIENTUL Bărbat, 60 de ani.

PLÂNGEREA Durere laterală între coaste și bazin după o zi de săpat.

EVALUAREA Înclinarea laterală + pe partea opusă. SLR -.

RAȚIONAMENTUL Pătratul lombar suprasolicitat.

HARTA DIN ATLAS

Harta 13 · Lombar — Pătratul Lombar · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

CE AȘTEPȚI Înclinarea mai puțin dureroasă după 1–2 zile.

13. Proaspăta mamă cu durere sacroiliacă

Zona lombară și sacrul

PACIENTUL Femeie, 31 de ani, la 4 luni după naștere.

PLÂNGEREA Durere în fesă și jos pe spate pe o parte, la urcatul scărilor.

EVALUAREA FABER + pe partea dureroasă. SLR -.

RAȚIONAMENTUL Zona sacroiliacă: X cu centrul pe articulație.

HARTA DIN ATLAS

Harta 14 · Sacru — Articulația Sacroiliacă · tăietură în X · Centru 25–50% · capete 0%

CE AȘTEPȚI Urcatul scărilor mai confortabil; program de stabilizare a bazinului.

14. Bărbatul cu durere care coboară în picior

Zona lombară și sacrul

PACIENTUL	Bărbat, 48 de ani.
PLÂNGEREA	Durere lombară care coboară pe spatele piciorului până sub genunchi, cu furnicături.
EVALUAREA	SLR + la 40°, cu durere sub genunchi.
RAȚIONAMENTUL	Semne de iritație a nervului: banda NU e prima alegere. Pacientul are nevoie de evaluare medicală înainte de orice aplicare.
HARTA DIN ATLAS	**Nicio aplicare.** Trimiți pacientul la evaluare medicală.
CE AȘTEPȚI	Nicio aplicare în această ședință.

> **Semnal de alarmă:** Amorțeală, slăbiciune în picior, tulburări de urinare sau de scaun: trimite imediat la medic.

PARTEA 6

Abdomen

2 cazuri.

15. Mama cu diastază

Abdomen

PACIENTUL	Femeie, 33 de ani, la 6 luni după naștere.
PLÂNGEREA	Abdomenul „se bombează” la ridicarea din pat.
EVALUAREA	Testul diastazei: spațiu de trei degete deasupra ombilicului.
RAȚIONAMENTUL	Suport pentru linia albă, ca ajutor pentru exercițiile de reeducare, nu în locul lor.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 18** · Abdomen — Diastază (Suport) · tăietură în I · Centru 25–35% · capete 0%
CE AȘTEPȚI	Senzație de susținere la exerciții; distanța se măsoară lunar.

Semnal de alarmă: Hernie dureroasă sau umflătură care nu se reduce: trimite la medic.

16. Studenta cu discomfort menstrual

Abdomen

PACIENTUL	Femeie, 22 de ani.
PLÂNGEREA	Crampe în zona suprapubiană în primele zile ale ciclului.
EVALUAREA	Fără alte simptome. Ciclu regulat, evaluat de medic.
RAȚIONAMENTUL	Aplicare de confort pe zona suprapubiană, cu tensiune mică.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 20** · Abdomen — Disconfort Menstrual · tăietură în X · Centru 25% · capete 0%
CE AȘTEPȚI	Senzație de confort; nu înlocuiește evaluarea ginecologică.

Semnal de alarmă: Durere foarte puternică, febră sau sângerare neobișnuită: trimite la medic.

PARTEA 7

Șold și fesieri

3 cazuri.

17. Alergătoarea cu durere laterală la șold

Șold și fesieri

PACIENTUL Femeie, 42 de ani, alergare de 30 km pe săptămână.

PLÂNGEREA Durere pe partea laterală a șoldului, mai rău culcată pe acea parte.

EVALUAREA Palparea trohanterului +. Trendelenburg + (bazinul coboară).

RAȚIONAMENTUL Două probleme: zona bursei și fesierul mijlociu slab. Stea pe zona dureroasă, apoi întărirea fesierului.

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 49** · Șold — Bursită Trohanteriană · stea din benzi în I · Centru 25–50% · capete 0%
- **Harta 46** · Șold — Fesierul Mijlociu · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%

CE AȘTEPȚI Durere mai mică noaptea; volumul de alergare redus temporar.

18. Taximetristul cu durere în fesă

Șold și fesieri

PACIENTUL Bărbat, 50 de ani, stă jos 10 ore.

PLÂNGEREA Durere adâncă în fesă, mai rău după mult timp la volan.

EVALUAREA FAIR +. SLR -. Fără amorțeală.

RAȚIONAMENTUL Piriform, fără semne de nerv: I pe piriform; dacă și fesierul mijlociu e slab, combinata.

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 47** · Șold — Piriform · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%
- **Harta 69** · Combinată — Șold: Fesier Mijlociu + Piriform · Y + I · Ambele 15–25%

CE AȘTEPȚI Durere mai mică după condus; pauze la 2 ore.

19. Dansatoarea cu șoldul „tras” în față

Șold și fesieri

PACIENTUL Femeie, 26 de ani, dans contemporan.

PLÂNGEREA Tensiune în fața șoldului la extensia piciorului.

EVALUAREA Testul Thomas + (coapsa se ridică de pe masă).

RAȚIONAMENTUL Iliopsoasul scurtat.

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 48** · Șold — Iliopsoas · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

CE AȘTEPȚI Extensie mai liberă la retest; întinderi zilnice.

PARTEA 8

Coapsă și ischiogambieri

2 cazuri.

20. Fotbalistul cu întindere la ischiogambieri

Coapsă și ischiogambieri

PACIENTUL Bărbat, 23 de ani, la 5 zile după o întindere ușoară, fără echimoză mare.

PLÂNGEREA Tensiune pe spatele coapsei la sprint.

EVALUAREA Lungimea ischiogambierilor redusă cu 25°. Echimoză mică.

RAȚIONAMENTUL Suport pe ischiogambieri și drenaj pentru echimoza mică: harta combinată.

HARTA DIN ATLAS **Harta 70** · Combinată — Coapsă: Ischiogambieri + Drenaj · Y + plasă · Y 15–25% · plasă 0–20%

CE AȘTEPȚI Revenirea la sprint treptat, nu doar pe baza benzii.

Semnal de alarmă: Pocnitură, echimoză mare sau imposibilitatea de a merge: trimite la medic.

21. Ciclistul cu durere laterală la genunchi

Coapsă și ischiogambieri

PACIENTUL Bărbat, 37 de ani, ciclism.

PLÂNGEREA Durere pe partea laterală a coapsei și a genunchiului după 40 km.

EVALUAREA Testul Ober +.

RAȚIONAMENTUL Banda iliotibială tensionată.

HARTA DIN ATLAS **Harta 29** · Coapsă — Banda Iliotibială · tăietură în I · Ancoră 0% · bandă 15–25%

CE AȘTEPȚI Durere mai târzie pe tură; verificarea poziției pe bicicletă.

PARTEA 9

Genunchi și rotulă

3 cazuri.

22. Jucătoarea de baschet cu durere la rotulă

Genunchi și rotulă

PACIENTUL Femeie, 17 ani, baschet.

PLÂNGEREA Durere în jurul rotulei la sărituri și la coborârea scărilor.

EVALUAREA Mobilitatea rotulei dureroasă. Genuflexiunea pe un picior + sub rotulă.

RAȚIONAMENTUL Rotula și tendonul sunt implicate amândouă: harta combinată.

HARTA DIN ATLAS **Harta 63** · Combinată — Genunchi: Rotulă + Tendon · Y + I · Y 15–25% · I centru 50–75%

CE AȘTEPȚI Genuflexiune mai puțin dureroasă la retest.

23. Schiorul cu genunchiul răsucit

Genunchi și rotulă

PACIENTUL Bărbat, 34 de ani, la 2 săptămâni după o răsucire, evaluat de medic.

PLÂNGEREA Durere pe partea internă a genunchiului.

EVALUAREA Testul în valgus: durere, fără deschidere mare.

RAȚIONAMENTUL Ligamentul colateral medial, deja evaluat: I cu tensiune mare în centru.

HARTA DIN ATLAS **Harta 24** · Genunchi — Ligament Colateral Medial · tăietură în I · Centru 50–75% · capete 0%

CE AȘTEPȚI Încredere mai mare la mers.

Semnal de alarmă: Instabilitate, blocaj sau umflătură mare: înapoi la medic.

24. Pensionara cu genunchiul umflat

Genunchi și rotulă

PACIENTUL Femeie, 68 de ani, evaluată de medic.

PLÂNGEREA Genunchi umflat după o plimbare lungă.

EVALUAREA Balotare +. Fără căldură sau roșeață.

RAȚIONAMENTUL Edem fără semne de inflamație acută: evantai pentru drenaj.

HARTA DIN ATLAS **Harta 25** · Genunchi — Edem · tăietură în evantai · Ancore 0% · benzi 0–20%

CE AȘTEPȚI Senzație de genunchi mai ușor; edemul se evaluează la fiecare ședință.

Semnal de alarmă: Genunchi cald, roșu, cu febră: nu aplica, trimite la medic.

PARTEA 10

Gambă

1 caz.

25. Maratonistul cu gamba obosită

Gambă

PACIENTUL	Bărbat, 41 de ani, se pregătește de maraton.
PLÂNGEREA	Crampe și greutate în gambă după antrenamentele lungi.
EVALUAREA	Ridicări pe vârfuri: mai puține repetări pe o parte. Fără durere pe os.
RAȚIONAMENTUL	Oboseală musculară și ușor edem: harta combinată gastrocnemian + drenaj.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 68** · Combinată — Gambă: Gastrocnemian + Drenaj · Y + evantai · Y 15–25% · evantai 0–20%
CE AȘTEPȚI	Recuperare mai rapidă între antrenamente.

Semnal de alarmă: Gambă umflată, caldă și roșie pe o parte: posibilă tromboză, trimite urgent la medic.

PARTEA 11

Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

3 cazuri.

26. Profesoara cu durere pe tendonul lui Ahile

Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

PACIENTUL	Femeie, 45 de ani, merge mult.
PLÂNGEREA	Durere pe tendon dimineața, la primii pași.
EVALUAREA	Ridicarea pe un călcâi + pe tendon. Fără pocnitură.
RAȚIONAMENTUL	Tendonul lui Ahile suprasolicitat; dacă și talpa doare dimineața, combinata cu fascia.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 36** · Gleznă — Tendonul Lui Ahile · tăietură în Y + I · Y 15–25% · I în centru 50% **Harta 72** · Combinată — Picior: Fascia Plantară + Ahile · evantai + I · Ambele 15–25%
CE AȘTEPȚI	Primii pași mai puțin dureroși; exerciții excentrice.

27. Jucătorul de fotbal după entorsă

Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

PACIENTUL	Bărbat, 20 de ani, la 3 săptămâni după o entorsă, radiografie normală.
PLÂNGEREA	Gleznă nesigură la schimbări de direcție.
EVALUAREA	Sertarul anterior: durere ușoară. Echilibru pe un picior mai slab.
RAȚIONAMENTUL	Instabilitate fără leziune osoasă: etrier, cu suport pe tendonul lui Ahile dacă e nevoie.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 38** · Gleznă · etrier în U · Centru 50% · capete 0% **Harta 64** · Combinată — Gleznă: Etrier + Ahile · U + I · U centru 50% · I 15–25%
CE AȘTEPȚI	Încredere mai mare la antrenament; exerciții de echilibru.

Semnal de alarmă: Durere pe os sau imposibilitatea de a călca: cere radiografie înainte de bandă.

28. Vânzătoarea cu durere sub călcâi

Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

PACIENTUL	Femeie, 39 de ani, stă în picioare toată ziua.
PLÂNGEREA	Durere sub călcâi, mai ales dimineața.
EVALUAREA	Windlass +.
RAȚIONAMENTUL	Fascia plantară: evantai.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 39** · Picior — Fascia Plantară · tăietură în evantai · Ancoră 0% · benzi 15–25%
CE AȘTEPȚI	Primii pași mai suportabili; încălțăminte cu suport.

PARTEA 12

Încheietura mâinii și mâna

1 caz.

29. Casiera cu furnicături în mână

Încheietura mâinii și mâna

PACIENTUL Femeie, 47 de ani.

PLÂNGEREA Furnicături în degetul mare, arătător și mijlociu, mai ales noaptea.

EVALUAREA Phalen + după 40 de secunde. Forța strângerii păstrată.

RAȚIONAMENTUL Zona tunelului carpian, fără slăbiciune: Y; dacă și încheietura e instabilă, combinata.

HARTA DIN ATLAS

- **Harta 51** · Încheietură — Tunel Carpian · tăietură în Y · Ancoră 0% · cozi 15–25%
- **Harta 66** · Combinată — Încheietură: Tunel + Stabilizare · Y + I · Y 15–25% · I 25%

CE AȘTEPȚI Mai puține furnicături la lucru.

Semnal de alarmă: Mâna stângace, slăbiciune sau amorțeală permanentă: trimite la medic.

PARTEA 13

Cot și antebraț

1 caz.

30. Tenismanul cu cotul dureros

Cot și antebraț

PACIENTUL	Bărbat, 43 de ani, tenis de 3 ori pe săptămână.
PLÂNGEREA	Durere pe partea externă a cotului la rever și la strângerea mâinii.
EVALUAREA	Cozen +. Strângerea pumnului dureroasă.
RAȚIONAMENTUL	Epicondilita laterală cu extensorii suprasolicitați: harta combinată.
HARTA DIN ATLAS	**Harta 67** · Combinată — Cot: Epicondil + Extensori · Y + două I · Y 15–25% · I centru 50%
CE AȘTEPȚI	Strângere mai puțin dureroasă; verificarea rachetei și a tehnicii.

Pasul următor

Alege cazul care seamănă cel mai mult cu pacientul tău de mâine și urmează aceiași pași. Notează în fișă ce a funcționat.